Lèpre, peste, variole et corona — « Faire vivre » comme maxime d'une gouvernementalité[1] bio-politique

André Bleicher

Quand bien même cela soit définitivement trop tôt pour la perspective d'une chouette de Minerve (Hegel 1972, p.14) — qui commence à s'envoler seulement à l'irruption du crépuscule — c'est-à-dire qui n'acquiert ses connaissances qu'à partir d'une rétrospective historique, parce que l'apparition de la crise sociale, politique et économique, déclenchée par le SARS-CoV-2-Virus, n'est encore en aucun cas réglée ou surmontée, presque tous les observateurs en science sociale sont tombés d'accord sur le fait que cette crise a causé une coupure globale et marquante dans les modèles socio-économiques et politiques d'interactions et de structures, et pour cette raison elle signale une césure historique.

Et pourtant : « Il n'y eut jamais autant de savoir sur notre non-savoir et sur la contrainte de devoir agir et vivre dans l'insécurité », constate Jürgen Habermas, eu égard à la pandémie de Corona et il recommande de la retenue à la science sociale au lieu de « pronostics inconsidérés » (Habermas 2020). Il a bien raison ! Et pourtant elle prend naissance sur la base de nombreux faits de désordres, d'actions précipitées et d'une politique qui doit se limiter à la mise en œuvre rapide de solutions satisfaisantes au désir de rigueur conceptuelle.

Michel Foucault en vint sans cesse dans ses œuvres principales à parler de la manière de fréquenter la société aux prises avec des maladies infectieuses ; il a ainsi développé trois modèles qui peuvent servir à donner du relief, pour comprendre plus précisément la crise de la corona et s'y adapter conceptuellement. En partant de ces modèles, on s'interroge, dans un second pas, sur la manière dont un élargissement de ces modèles peut être adapté et si une fréquentation sociétale solidaire est possible dans la pandémie.

Michel Foucault — la naissance de la gouvernementalité comme résultat des maladies infectieuses ?

« À la fin du Moyen-Âge » — ainsi Michel Foucault (1973, p.19) commence-t-il son premier grand ouvrage « *Folie et société* » — la lèpre disparut de l'Occident ». À coup sûr, la lèpre n'en disparut pas complètement, mais, et cela importe à Foucault, les léproseries[2], et donc les lieux où les malades de la lèpre étaient isolés, se désertèrent et leurs biens furent transmis aux pauvres. C'est pourquoi le récit de la lutte étatique contre les maladies infectieuses commence par le combat contre la lèpre.

« Faire mourir » — Le modèle d'exclusion : la lèpre

La lutte contre la lèpre suit, pour Foucault, la procédure simple mais rigoureuse et efficace de l'exclusion (Lorey 2009, p.1). Sitôt que les malades pouvaient être identifiés à l'intérieur des cités, ils étaient amenés devant les murs de la cité et abandonnés à leur sort dans des léproseries. Selon Foucault (1994, pp.254 et suiv.), le lépreux est rejeté, exclu, banni : exposé au dehors, on le laisse dépérir dans une masse qu'il ne vaut plus la peine de différencier. » À l'intérieur de l'espace clos des murailles de la ville, aucune infection ne menace plus et la « population normale » n'est que peu affectée par les mesures de protections. Le modèle socio-médical, dans la lutte contre la lèpre suit le rêve d'une « société pure » qui s'est débarrassée des impurs.

Cette structure de l'exclusion — là-dessus Foucault attire l'attention — persiste, une fois exercée comme modèle, même encore après que le danger de la lèpre était déjà devenu historique. Et Foucault (1973, p.23) continue : « *Souvent on peut en arriver en un même lieu, deux ou trois siècles plus tard, à la même formule d'exclusion dans une similitude ahurissante. Pauvres, vagabonds, condamnés et « têtes égarées », jouent le rôle qui était autrefois détenu par les lépreux (...) ».*

La thèse de Foucault de la mise à part des déviants, et avant tout des fous, reprend — tel est le fond de la thèse — le modèle de l'exclusion, celle-ci sert l'ardent désir sociétal d'écarter ceux qui sont différents et fait naître un souhait de séparation, d'exclusion et de purification qui fut éprouvé jadis, à l'époque de la lèpre. Cela étant, les léproseries ne servent plus à isoler les lépreux, bien plus, la structure d'exclusion se voit mise en œuvre pour tous les cas de comportements déviants, spécialement sur les fous, que l'on arrêtait, comme autrefois les lépreux — leurs voix, encore audibles au Moyen-Âge et au début des temps modernes, disparurent derrière les murs des établissements. Foucault essaya, avec son livre *Folie et société*, de redonner une voix à l'opprimé qui suscite le scandale des autres, parce que ces acteurs — bloqués qu'ils étaient autrefois — ne pouvaient plus apparaître au plan sociétal. Et en tant qu'exclus, ils ne sont plus en situation d'élever la voix ni d'exciper contre les projections des « normaux », au moment où ceux-ci, vers la fin de l'*ancien régime*, projetèrent leurs angoisses — décrites en concepts médicaux — sur les incarcérés : « *On s'épouvantait d'un mal amplement mystérieux qui, émanant des maisons d'internement, comme on l'affirmait, se répandait et allait bientôt menacer les villes. On parlait de fièvre des prisonniers, on renvoyait aux charrettes de condamnés, à ces hommes enchaînés qui traversaient les villes en laissant derrière eux une trace du mal. Des forces infectieuses imaginaires étaient attribuées au scorbut, on prévoyait que l'air corrompu par le mal détruirait les zones d'habitations* » (Foucault 1973, p.360). Désormais les exclus, avec les épidémies qui émanaient des hôpitaux et des asiles de fous, menaçaient les villes, qui étaient ensuite infiltrées de « putridité et de vices » (Foucault 1973, p.362).

Cela ne surprît pas lorsqu'en 1780, l'origine d'une épidémie à Paris fut attribuée à l'*hôpital général* et que l'on parlât aussi d'aller mettre le feu aux édifices du *Bicêtre* et donc à l'asile d'aliénés, parce qu'une fièvre putride se propageait là-bas. À la fin, du 18ème siècle, la société perçut comme foyers de conflits, non seulement les asiles d'aliénés, mais encore des hôpitaux ordinaires. Aux médecins, ceux-ci apparaissaient, sur la base du confinement des malades avec leurs exhalaisons diverses, comme des lieux où la maladie — quoi que cela puisse vouloir dire — pouvait nettement s'exprimer ; c'étaient des lieux où les pauvres pouvaient mourir et donc, pour ainsi dire, autant de foyers d'infections dangereux qui menaçaient la société.

« *On voit comment prennent naissance les thèmes d'un mal aussi bien physique que moral qui se ramifie dans toutes les directions, et comment ce mal renferme, dans cette irrésolution-là, des forces confuses de la corrosion et de l'épouvante. En cela domine un tableau indifférencié de la pourriture qui concerne autant la dépravation des mœurs que la décomposition de la chair et qui conjugue le mépris et la compassion que l'on ressent pour les internés. Le mal commence à fermenter tout d'abord dans des espaces d'internement clos. Il possède toutes les forces que l'on confère aux acides de la chimie du 18ème siècle : ses fines particules piquent à l'instar d'aiguilles et pénètrent dans les corps et les cœurs, tout aussi aisément que si elles étaient des particules basiques, passives et friables. Le mélange bout et déborde même, en libérant des vapeurs nocives et des liquides corrodants (...) Ces vapeurs brûlantes s'élèvent et se répandent dans l'air en retombant finalement dans les environs, en imbibant les corps et atteignant les âmes. On parfait ainsi en*

1 Le titre reprend la formulation de Michel Foucault : « Faire vivre et laisser mourir ».

2 Voir pour mieux comprendre la question des léproseries, lire : Victoria Hislop : *L'île des oubliés* (traduit de l'anglais par Alice Delarbre), édition les Escales 2012 ISBN : 978-2-253-16167-7. www.livre-de-poche.com *Ndt*

images les idées d'une infection par la pourriture. L'agent sensible de cette épidémie-là, c'est l'air, cet air qu'on appelle « corrompu », en comprenant là-dessous obscurément, qu'il n'est pas identique à l'air pur de la nature et forme l'élément transmissible du mal ». (Foucault 1973, p.361).

La métaphore de l'infection sert à la société en cela pour saisir en mots les possibles dangers diffus d'un mal menaçant et la lèpre représentait toujours et encore le modèle épidémiologique pour cette peur de l'infection. Sauf que la société ne pouvait désormais plus bannir le mal hors des murailles de la ville, comme au Moyen-Âge, il s'agissait beaucoup plus, non pas d'exclure la souillure, mais de la réduire, en détruisant les saletés et les vapeurs, en calmant toutes les fermentations et en les empêchant, ainsi que le mal, de corrompre l'air et de « répandre l'infection dans l'atmosphère des villes » (Foucault 1973, p.364). Mais il s'agissait en premier lieu, non plus d'exclure, mais d'éviter et d'y parer par une discipline.

« Faire vivre » — le modèle du disciplinement : la peste

Dans son ouvrage *Surveiller et punir*, publié en 1975, Foucault explore comment il devint possible que, dans une époque où les droits de l'homme et la liberté de l'individu étaient proclamés, où les têtes des rois roulèrent à terre, où la peine « humaine » de l'emprisonnement repoussait la loi sanglante du talion et où le pouvoir cessait de menacer de mort, et donc de « faire mourir », le disciplinement et la soumission sous un pouvoir n'en cessèrent guère pour autant et même se renforcèrent au contraire. Et de nouveau, il débute sa recherche, non pas en mettant au premier plan la structure sociale du disciplinement, mais en dépeignant au contraire la manière dont la peste fut combattue au 17ème siècle. Le chapitre le plus souvent cité, tiré de *Surveiller et punir*, l'analyse du panopticon de Bentham, ne commence pas par l'idée de Bentham, mais par une description de la manière dont les sociétés du 17ème siècle menèrent leurs confrontations avec la peste. À présent Foucault ajoute au modèle d'exclusion (de la lèpre) une autre modèle, celui de l'emprisonnement. Emprisonnement veut dire alors un contrôle disciplinaire imposé à l'acteur confiné dans l'espace ou la peste se répand.

Foucault (1994, p.255) nous montre à présent qu'un changement profond s'est accompli dans le traitement des épidémies, tandis que sur « l'espace d'exclusion qui était symboliquement habité par le lépreux (et de fait l'est désormais par des mendiants, vagabonds, déments, malfaisants), fut mise en œuvre la technique de pouvoir d'une discipline parcellisée ». Foucault dégage, à l'appui des comptes rendus du 17ème siècle, comment les villes, communautés et villages s'y prenaient avec l'irruption de la peste : comment en cas de peste, les malades, médecins, aidants, fossoyeurs, religieux et finalement l'ensemble de la population furent bureaucratiquement appréhendés et spatialement ordonnés, pour endiguer la peste et pour la surmonter. « La peste » comme le formule en 1947, déjà, Albert Camus (2000, p.204) dans son célèbre roman homonyme, « (...) n'avait rien à faire avec des grands tableaux émouvants (…). Elle était en premier lieu une gestion circonspecte, sans fautes et fonctionnant bien.[3] »

Camus décrit comment les stratégies mises en œuvre pour lutter contre la peste suivent un système de contrôle aux mailles très serrées qui, au moyen de mécanismes d'inclusion et d'exclusion très complexe, s'empare des malades et de ceux qui sont en bonne santé en les fixant au plus précisément dans le temps et l'espace. Dans cette mesure, la roman se lit à l'instar d'une anticipation de la parcellisation exposée par Foucault (1994, p.138). À cette occasion, il s'agit d'un « principe de localisation élémentaire » et d'une enclosure territoriale dans laquelle l'individu est renvoyé à une place spécifique et où à chaque place, un individu est posté. On est censé y éviter (...) des répartitions de groupes, de décomposer des pluralités massives (…) dont on ne voit pas l'ensemble » (Foucault 1994, pp.138 et suiv.). Cette parcellisation est censée avant tout protéger des porteurs de la peste qui peuvent la transmettre de sorte que des cloisonnements naissent, dans lesquels infectés et non-encore infectés se rencontrent et que les vagabondages soient arrêtés. Il s'agit de constater, par cette « *statique d'anti-désertion, d'anti-vagabondage, d'anti-agglomération (…) des présences et des absences ; de savoir où et comment on peut trouver les individus ; d'installer les canaux de communication les plus utiles et de briser ceux des autres ; qu'à chaque instant, de pouvoir surveiller, évaluer et sanctionner le comportement de chacun* » (Foucault 1994, pp.183 et suiv.).

L'inversion de la visibilité

Cela est donc le modèle de la peste : « Cet espace surveillé, parcellisé et sans lacunes, dans lequel (..) chaque individu est constamment saisi, vérifié et trié parmi les vivants, les malades et les morts — ceci est le modèle compact d'une disposition disciplinaire » (Foucault 199 p.254). Avec cela, la procédure est caractérisée par laquelle la peste est censée être contrôlée. En elle s'inverse carrément « l'économie de visibilité traditionnelle » (Foucault 1994, p.241). Alors que pendant l'*ancien régime*, le roi était visible et ses sujets demeuraient dans l'invisibilité. Avec la vérification et donc la méthode qui contrôle une justesse et une répression de parcellisation, se produit une inversion de visibilité. Ceux qui sont chargés de la vérification, donc le roi, le président [conseil de « défense », *ndt*] et aujourd'hui la chancelière, passent à l'arrière-plan dans la lutte contre la peste — ils deviennent visibles au-dessus de leurs représentants (agents). Dans le faisceau de lumière du projecteur — devenant ainsi visibles — sont placés les sujets qui sont à contrôler et ceci se produit particulièrement aussi du fait que la vérification s'effectue selon certains rythmes et intervalles, et que de cette manière un ordre temporel surgit qui renforce et complète la spatialité de la parcellisation.

L'inversion du régime de visibilité transforme les stratégies médicales de lutte contre la peste en un pouvoir disciplinaire socio-politique qui s'impose, non pas en ne plaçant pas les structures de pouvoir à l'avant-plan, mais au contraire, en octroyant aux surveillés une présence inconditionnelle : sur la base d'une possibilité existante de manière permanente d'être vu, le pouvoir érige un réseau aux mailles très serrées de soumission du sujet sous la discipline du modèle de la peste. La surveillance est sans lacunes.

« *Aux portes de la vile des postes de garde, de même à la fin de chaque rue. Chaque jour l'intendant chargé d'un quartier de la ville, enquête, il s'informe pour savoir si les syndizi ont fait leur travail et si les habitants ont à s'en plaindre (…) Chaque jour le syndicus sort dans la rue dont il est responsable ; il s'arrête devant chaque maison, et fait paraître ses habitants à leur fenêtre (…) ; il fait l'appel de chacun par son nom et s'informe de l'état de chacun, à l'occasion de quoi, les habitants sont forcés de dire la vérité, sous peine de mort (…). Chacun est emprisonné dans sa cage, chacun doit se montrer à sa fenêtre et à l'appel de son nom, il doit répondre à ce qu'on lui demande (…)* » (Foucault 1994, p.252).

Le combat contre la peste se sert d'un appareil disciplinaire et d'un appareil d'état, qui suit la logique de l'enfermement et qui place la région contaminée sous le régime d'un protocole et d'une identifica-

3 Le roman d'Albert Camus est à lire comme une parabole, dans lequel la peste représente une métaphore. Le roman ne traite pas d'une peste mais des acteurs et de leurs agissements précisément en temps de peste. Certes des symptômes angoissants richement détaillés du déroulement et de la dynamique d'une irruption de peste sont décrits : la peste intervient en détruisant un état de vie normal et les individus et autorités réagissent exactement à partir de cet état. Alors que l'histoire en apparence traite d'une irruption de peste, celle-ci a été pourtant comprise, depuis son apparition en 1947, comme une parabole de l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Les principaux personnages: le docteur Rieux, qui se concentre sur la lutte contre la peste, ce qu'il peut faire avec un savoir médical et l'énergie humaine, l'activiste politique Tarrou et le jésuite Paneloux, qui s'opposent sans illusions mais solidairement à l'épidémie, pour l'amour de la liberté, de la justice et de la dignité, représentent un panorama d'acteurs des groupes qui se sont rassemblés dans la Résistance. Si, donc, on lit ce roman sur le fond de la pandémie coronaïque, alors celui-ci apparaît comme une défection et une fuite dans l'abstraction et une exhortation au discernement qui est justement le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais l'indifférence — car justement les protagonistes principaux s'opposent à celle-ci.

tion des plus précis. On peut seulement mettre un terme au désordre dé-normalisant, engendré par l'irruption de la peste dans une société ordonnée auparavant, au moyen d'un système radical d'ordre et de normalisation. C'est pourquoi un système de normalisation est érigé et édifié qui sanctionne l'infection et la contamination. Dans un tel système une anormalité est caractérisée comme pathologique et préventivement combattue. Ici la mise en opposition de l'infection et de l'ordre, qui revient sans cesse dans l'œuvre de Foucault, est à reconnaître, ainsi que le « rêve », de la part des autorités compétentes, d'un ordre qui reflète aussi l'angoisse de l'infection, de la révolte, du délit, du vagabondage, de la désertion…

C'est seulement à cet endroit que la voie étroite du panopticon de Bentham devient compréhensible car un propagateur de l'idée d'une surveillance englobante dans un panopticon, c'est précisément cette angoisse devant ce-qui-n'est-pas-normal. Ainsi Bentham construit un édifice circulaire avec des cellules séparées de tous contacts les unes des autres, mais toutes directement visibles, formant une tour centrale, où quelques gardiens suffisent pour communiquer à tous leurs occupants qu'ils sont durablement contrôlés. Et ce système de disciplinement peut être sociétalement transposé, de la prison aux militaires, aux écoles, aux entreprises, de sorte que Foucault dans son chapitre conclusif « Surveillance et punition » ébauche la société à l'instar d'une grande prison dans laquelle chaque sujet fonctionne comme un « rouage » de cette machinerie (Foucault, 1994, p.279). Le modèle de la peste représente aussi, pour ainsi dire, un prototype de régulation sociétale qui peut non seulement être utilisé en cas d'épidémies, mais encore être transposé, en tant que structure une fois développée, à tous les domaines multiples de la société, aussi pour la raison qu'il réussit à transformer les contraintes extérieures du disciplinement au moyen d'un exercice durable de routines de sorte que cette discipline est pour ainsi dire internalisée par le sujet. (Voir comme exemple, la transposition sur le domaine de l'entreprise de l'article d'Alfred Kieser en 1998).

Les deux modèles (lèpre et peste) peuvent être compris avec Foucault (2001) comme formant une polarité dans le rétrécissement formulé dans son cours « *En défense de la société* ». Si le souverain de l'*ancien régime* pouvait encore menacer ces sujets de mort, et avec cela il pouvait les « faire mourir » ou bien encore les « laisser vivre », ainsi dans les temps modernes une inversion de cette formule a lieu, pour ainsi dire. Dans le modèle de la peste il s'agit de maintenir en vie et donc de « faire vivre ».

« *La souveraineté faisait mourir et laissait vivre. Un pouvoir fait à présent son apparition que je caractériserais comme un pouvoir régulateur et qui consiste au contraire à faire vivre et laisser mourir.* » (Foucault 2001, p.291)

La vie entre ainsi au centre de l'action étatique — c'est la naissance de la biopolitique.

La gouvernementalité comme un nouveau début — le modèle de la variole

Le modèle de la peste ne représente nonobstant pas le dernier mot de Foucault au sujet de la lutte contre les épidémies. Au moment où, en en janvier 1978, Foucault reprend sa place au pupitre de la chaire du *Collège de France*, il s'écarte de la représentation développée dans son chapitre conclusif « *Surveillance et punition* », à savoir qu'un gouvernement moderne se laisse comprendre à l'instar d'un modèle de prison idéale. Tout d'abord, il suit la question de savoir si l'on peut élargir les formes de contrainte et d'oppression du système de la lutte contre la peste au niveau de sociétés entières. Cela ne lui apparaît plus possible et il oppose donc un refus à cette représentation. : « *Bon, je crois que j'avais tort* ». (Foucault 2004, p.78) Et il pose la question nouvelle de savoir comment il a été possible aux société européennes de pouvoir surmonter l'état policier absolutiste ; et pourquoi donc l'état moderne — à l'exception du fascisme et du stalinisme — n'apparaît-il pas comme un état policier, mais au contraire comme une démocratie libérale ?

Pour rendre clairs, non seulement ce changement historique, mais encore le virage de son propre penser à ce propos, Foucault (2004, pp.25 et suiv.) remet en mémoire à ses étudiants les cas qu'il avait déjà travaillés en détail : la lèpre qui produit un type de pouvoir, utilisant un code binaire et divise la société en personnes saines et personnes malades. Puis la peste, qui répond d'un type de pouvoir qui pourvoit les villes d'un réseau de contrôle aux mailles fines et institue un système de disciplinement. Et ensuite il présente le nouveau modèle de la variole qui se fie aux pratiques vaccinales :

« *Le problème se pose* [ici, A.Bl.] *tout autrement, ce n'est pas tant celui d'aller jusqu'à imposer une discipline (…), le problème de fond, c'est beaucoup plus de savoir combien de gens sont infectés par la variole, de quels âges, avec quelles conséquences, quelle mortalité, quels dommages et répercussions sur leur santé, quel risque prend-on quand on se fait vacciner, à quelle hauteur se situe la vraisemblance d'en mourir ou bien, en dépit de la vaccination, de tomber malade de la variole, quelles en sont les répercussions statistiques en général, bref : un problème qui n'a plus du tout à voir avec celui de l'exclusion lors de la lèpre ni non plus celui de la quarantaine pour la peste, mais bien plus le problème des épidémies et des champs* [d'affrontements, ndt] *médicaux avec lesquels on tente d'endiguer des phénomènes épidémiques ou pandémiques.* »

À la différence de la stratégie disciplinante, de défense contre la peste, les autorités des 18ème et 19ème siècles réagirent en premier lieu par la vaccination, ainsi que par des mesures gouvernementales basées sur la statistique en appréhendant la quantité de cas de cette maladies — et de manière empirique/pratique — elles tentèrent de protéger la population de l'infection. La vaccination contre la variole représente pour Foucault, un exemple de ce qu'il qualifie, dans son cours sur le thème de la gouvernementalité, comme un « dispositif de sécurité », pour préciser la technique « biopolitique » propre au gouvernement libéral : il ne s'agit plus pour la société d'exclusion ou de disciplinement, mais au contraire de sécurité et de normalisation (statistique) — et il s'agit donc que la démocratie libérale puisse s'établir comme une alternative aux techniques disciplinaires de la « surveillance et la punition ».

Formulé autrement : avec la vaccination contre la variole et le développement du concept de « dispositif de sécurité », il ne s'agit plus d'exercer sur le territoire une domination disciplinaire (ce serait alors un « dispositif disciplinaire »), mais d'une « gouvernance » de la population et de sa « régulation ». Il ne s'agit plus non plus de « l'instauration d'un état fort », car un état fort détruit ses propres buts, puisqu'il dût enterrer la liberté sociétale requise et inhérente au système. Ou bien, comme Foucault (2001–2005, p.522) le formule : « (…) trop gouverner veut dire ne plus gouverner» — mais ce qui signifie aussi que l'état accepte « l'opacité » de la société, au prix de certains risques — normaux — d'infection.

Le dispositif de sécurité émane donc d'un concept de normalité appréhendé de manière statistique ; une normalité au sens d'existence, de survenance de cas et de courbes de distribution à l'intérieur de la population. Le dispositif de sécurité ne tente pas en attendant de discipliner mais bien plus de comprendre la nature de la maladie et de gouverner à la rencontre des risques qui en résultent. Formulé autrement, le modèle-variole, comme l'ébauche Foucault, consiste à renoncer essentiellement au rêve d'éliminer complètement le pathogène, les germes de maladie, les intrus dans les corps, de surveiller la société et de discipliner toutes les actions des acteurs. Une société coexiste à présent avec une maladie infectieuse, elle relève les données de propagation, produit des statistiques et lance des « campagnes médicales » qui peuvent aussi prendre un caractère normatif. Mais un disciplinement et une normalisation universels ne représentent pas des buts raisonnables de la démocratie libérale — là où elle s'y efforce toutefois, là où la société rétrograde durablement du modèle-variole au modèle-peste, là elle devient alors totalitaire.

La ville ouverte

Le concept de la « ville ouverte » est central pour le modèle-variole. Les ports et villes de commerce, dans lesquels les mouvements de marchandises se produisent certes dans les règles, mais sans devoir être arrêtés justement, représentent un modèle (néo)libéral pour la

société du même nom : des villes, en tant que points de jonctions qui vivent du fait que des acteurs et des marchandises peuvent librement y affluer et en venir. En cas d'épidémie cependant, l'accès en est seulement possible si l'on dispose d'un vaccin approprié pour l'immunisation de la population. Le modèle-variole dans ce sens part du fait que des maladies et les réactions du système immunitaire sont quelque chose de « naturel » et que leur évolution suivent des modèles statistiquement concevables — le déroulement d'une épidémie est donc modifiable certes par la vaccination, mais il n'est pas à arrêter totalement par ce moyen.

Dans l'analyse du modèle-variole, Foucault (2004, p.79) part de la liberté de l'individu, qui lui « apparaît comme quelque chose d'absolument fondamental » qui ne se trouve pas à disposition. Dans ce sens, la gouvernementalité moderne lui apparaît comme une forme de gouvernement « qui ne peut se réaliser qu'en s'appuyant par la liberté et sur la liberté de tout un chacun. » Or, cette liberté limite fondamentalement le pouvoir, elle est pour Foucault incontournable et non disponible.

Foucault analyse cette nouvelle forme de « normalisation » à l'exemple du modèle-variole qui tout d'abord ne pouvait pas du tout être mis en accord avec les théories médicales existantes.

« À *partir de 1720* [on disposait, ; A.Bl.] *avec ce qu'on a appelé vaccination ou variolation, et ensuite à partir de 1800 avec la vaccination, de techniques (…), qui possédaient quatre caractères, absolument inhabituels pour la pratique médicale courante de l'époque :* ***1.*** *le fait d'être absolument préventives,* ***2.*** *le fait d'être assurées d'avoir un succès presque total,* ***3.*** *d'être généralement mises en œuvre en principe et sans difficultés matérielles ou économiques sur l'ensemble de la population ; et pour finir,* ***4.*** *et avant tout la variolation ou même encore le principe de vaccination, s'avérait tout d'abord, au début du 19ème, siècle totalement étrangère à toute théorie médicale. La pratique et le succès de la variolation et de la vaccination étaient inconcevables dans les concepts de la rationalité médicale contemporaine. Ce fut une donnée factuelle pure, (…) et certes jusqu'à ce que la médecine, au milieu du 19ème siècle, à peu près avec Pasteur, devînt capable de saisir rationnellement ce phénomène.* » (Foucault 2004, p.91)

Sur la base de ces caractéristiques par la possibilité de la variolation, les techniques de gouvernement purent changer fondamentalement au plan structurel et la pratique de la vaccination — tout d'abord dépourvue de toute théorie — put intégrer le calcul du risque, au moyen de méthodes statistiques. Si le risque de tomber malade est statistiquement mesurable, et que l'on rend contrôlable la politique de santé soumise à une évaluation empirique-quantitative, alors un dispositif de sécurité se laisse construire et diriger vers la pratique.

Cette pratique Foucault l'appelle « biopolitique » ; ce qu'il veut désigner par ce terme ce sont les qualités biologiques de la population, en tant qu'êtres vivants biologiques-corporels rendus visibles au moyen de statistiques : taux de naissance, de mort, état de santé et maladies, état d'alimentation, comportements au travail et d'habitation, etc. Une biopolitique, dans l'esprit de Foucault, n'est pas orientée sur la maîtrise des corps, mais elle suit au contraire le modèle de démocratie libérale qui s'efforce à une limitation du gouvernement et se distingue en ouvrant à la société l'espace de liberté le plus grand possible.

La position de vacuité de ce modèle est aussi caractérisée en suffisance avec cela : le modèle (néo)libéral de Foucault lui-même ne connaît aucun concept de société formant un tout, en tout cas le concept biologique de population peut s'étendre à une masse amorphe d'hôtes potentiels, dans laquelle le virus peut se propager.

Application sur la crise coronaïque

Si l'on applique les trois modèles de Foucault sur la crise coronaïque, alors il devient évident que l'action des gouvernements dans les démocraties libérales s'est essentiellement laissée guider par le modèle-variole : des concepts tels que « mortalité normale », « surmortalité », « immunité de groupe » ou « aplatissement de la courbe », démontrent clairement combien le dispositif de sécurité fut fortement placé sur celui de la variole, il va de soi qu'il fut transformé et adapté à l'égard des conditions de la maladie corona. Cela représente une performance des démocraties libérales — laquelle n'est qu'insuffisamment estimée — qu'elles ne se sont pas principalement appuyées, eu égard à la crise, sur le modèle de la peste — comme certains commentateurs l'ont exigé — elles n'ont pas poursuivi une politique pandémique plus forte de manière autoritaire, en suivant l'exemple de la Chine.[4]

On reprocha même en partie aux démocraties libérales en comparaison des régimes structurés de manière autoritaire, qu'elles n'aient pas eu recours à la possibilité d'exercer la contrainte. Il faut objecter à cela que les démocraties libérales — avant tout dans la phase où aucun vaccin ne se trouvait à disposition — ont entrepris des recours au modèle de la peste et ont tenté d'entraver la propagation du virus au moyen de « quarantaines ». Il fut foncièrement possible aux démocraties libérales — éventuellement à l'étonnement des médias et de la population —sur une période déterminée de se reposer sur des techniques disciplinaires [confinements en France, *lockout* ailleurs *ndt*], sans que pour autant — cela vaut d'être souligné — que la démocratie libérale fût mise en danger dans sa substance.[5]

Il apparaît cependant plus important qu'elles n'en soient pas retombées non plus au modèle de la lèpre, ni qu'elle ait suivi une politique d'exclusion. La ségrégation des groupes à risques, qui ne cesse d'être débattue, pouvait certes être interprétée ainsi, mais on ne voit pas cependant qu'il ne s'agit plus d'un «faire mourir», mais d'une performance d'inclusion du « faire vivre », qui protège précisément ce groupe et le maintient solidairement dans la société. Une politique de santé dont l'action s'oriente sur l'évitement de triage montre qu'elle veut éviter des exclusions et le « faire mourir ».

On ne peut pas grever les démocraties libérales de régression, au contraire, elles se sont préservées dans la crise, on pourrait même parler de la corona comme étant l'heur des démocraties, s'il n'y eût point un manque à constater qu'il vaille encore d'explorer plus précisément la faculté oubliée de solidarité sociétale.

Politique pandémique solidaire — des masques et préservatifs

Le défaut du modèle-variole consiste à ne pouvoir concevoir une société que comme un rassemblement de corps biologiques, lesquels peuvent être certes vaccinés, mais ils **ne** se trouvent par ailleurs, en relation les uns avec les autres **que** selon le précepte du « *survival of the fittest* [= « *de la survie du plus adapté* », en anglais dans le texte et ce n'est pas du tout du tout un hasard ici ! *Ndt*]. Dans cette mesure, les démocraties libérales transposent le modèle économique de la concurrence sur les processus biologiques et réduisent de cette manière toute action à une action de type biologique. Dans la situation d'une pandémie, nonobstant l'action attentive, à savoir l'action solidaire, joue un très grand rôle et cela pour éviter l'infection. En vérité la véritable question à se poser doit avoir la teneur suivante : des pratiques collectives — et non pas individuelles — sont-elles possibles qui contribuent effectivement à la santé de la population et englobent aussi des changements de comportements sur une grande échelle, sans pourtant retomber sur des modèle de disciplinement ou de surveillance ? Donc le modèle-variole peut-il être complété au plan social ?

Foucault lui-même, à la fin de sa vie, dans la confrontation avec la philosophie antique, a proposé une politique qui tente de relier les sollicitudes individuelle et collective sans contrainte. À partir d'une telle perspective, des résolutions de distanciation sociale pendant une épidémie, mais aussi des résolutions sur l'interdiction de fumer

4 Lea Deuber, correspondante en Chine de la ***Suddeutsche Zeitung***, a composé dans le numéro **80** (du 4/5.4.2020, p.8) une « *Chronique du temps perdu* » qu'elle a eu en propre. Qui la suit ne peut que nourrir le doute croissant à propos de l'efficacité affirmée des régimes autoritaires.

5 Néanmoins il faut remarquer que les démocraties libérales eussent pu mieux résister à la première phase de la pandémie coronaïque, si elles n'avaient pas tiré vers le bas l'économie de leur système de santé et si elles avaient pu disposer de plus de capacités de réponse en cas de crise.

dans les espaces publics, seraient tout d'abord discutées dans des forums publics et prises ensuite collectivement. De cette manière une transformation des attitudes individuelles d'une simple discipline en responsabilité pourrait survenir. Toutefois responsabilité, signifie ici nonobstant responsabilité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Ainsi se laisse éventuellement surmonter l'état d'angoisse ou de peur, individualisé de manière permanente — dans lequel toute relation sociale court un danger constant de se briser — et l'idée d'une contention [= un grand effort, *ndt*] collective peut faire son apparition à la place de la perte de l'individu. Une coordination et une solidarité autogérées dans un combat ensemble contre la pandémie — de tels éléments n'ont pas été développés jusqu'à présent en temps de pandémie, or ils pourraient s'avérer toutefois tout aussi importants que l'intervention médicale ciblée et représenter une évolution ultérieure du modèle-variole.

L'obligation du masque en Tchéquie

Un exemple d'un tel élargissement solidaire s'est développé en Tchéquie, au début de l'épidémie coronaïque. La question du port du masque fut soulevée comme une exigence des mouvements sociaux sur place et donc par des acteurs de la société civile et par l'intermédiaire des médias, elle put engendrer un large mouvement favorable (Kotíková 2020). Or, ceci se produisit, à l'encontre du conseil donné par l'OMS, qui considérait une obligation du port du masque comme non foncièrement ciblée et l'avait même classée comme une mesure contre-productive [?, *ndt*]. Le gouvernement tchèque lui-même ne souhaitait guère reprendre la mesure, bel et bien pour la bonne raison qu'il redoutait qu'il n'y eût pas assez de masques disponibles. Mais après que ce mouvement spontané, par la propagation d'instructions et de recommandations massives de proximité (*Nähanweisungen*) fut en mesure de produire lui-même assez de masques, le gouvernement reprit la mesure et prononça l'obligation du port du masque. Mais au fond, il s'agissait là d'un acte démocratique de la production du savoir, une formation de volonté et de consensus émanant « d'en bas ». Et le point central d'une telle initiative, c'est la construction d'un comportement réciproque en relation avec une communauté solidaire qui a réussi après avoir pesé entre restriction personnelle et facilitations de libertés.

La mesure — donc porter un masque qu'on a soi-même cousu — ne protège pas contre une infection, tel est l'état actuel du savoir, mais le masque empêche d'infecter d'autres personnes, dans la mesure où l'on est soi-même infecté. Mais il ne s'agissait pas d'imposer l'obligation du port du masque aux personnes infectées — ce qui eût été le résultat d'une sélection sociale ; laquelle par ailleurs n'eût été de toute manière réalisable qu'au moyen de tests couvrant toute la zone et d'un soutien policier — mais il s'agissait au contraire que tous les acteurs portent des masques afin de rompre efficacement le plus tôt possible toute survenance de chaînes de contaminations. La différence est très importante : au lieu d'exclure les personnes infectées, conformément aux modèles de la lèpre et de la peste, la façon de faire des membres de la société civile tchèque a évité l'isolement de quelques-uns et promu, puis établi, un modèle de solidarité collective à l'instar « d'un mouvement au-raz-des-pâquerettes ». En comparaison à cela, l'obligation du port du masque en Allemagne — qui fut introduite, non pas en incluant une procédure participative, mais au contraire par une sorte de décret exécutif — opérait quant à elle plutôt comme un acte du disciplinement (et donc du modèle de la peste).

Si nous devons nous installer sur le long terme à vivre avec la pandémie — et quelques éléments parlent en faveur de cette éventualité — l'élargissement du modèle-variole gagne en importance, puisque de cette façon, l'acceptation et la libre volonté des mesures sont plutôt encouragées et non plus dénoncées comme autoritaires par une partie de la population. C'est pourquoi il faut ici attirer l'attention sur un chapitre oublié de la lutte contre la pandémie. Cela se présente historiquement dans les expériences acquises par la lutte contre l'épidémie-SIDA des années 1980 qui démontraient un caractère démocratique-solidaire.

La crise-SIDA

Ce qui est intéressant dans cette crise, c'est que le modèle de réaction des premières années, après que la maladie fut connue, peut être à son tour classé dans le schéma de Foucault. Une vaccination contre le SIDA n'est toujours pas à disposition, c'est pourquoi le modèle-variole doit nécessairement échouer. Deux manières de réagir s'opposaient diamétralement pour ce débat : Peter Gauweiler et Horst Seehofer préféraient une amorce d'exclusion policière qui s'appuyait sur l'ordonnance épidémiologique du *Bundestag* : des décrets furent discutés sur les lieux de risques, les dépistages, une obligation d'informer et de communiquer, l'isolement des malades, la quarantaine, et même l'hospitalisation en camps spéciaux, pour rompre la chaîne d'infection. Et donc pour l'essentiel, on suivait le modèle de la peste avec des éléments fort du modèle de la lèpre (camps). ***Der Spiegel*** (Dannecker 1986) fonctionna alors comme le porte-voix de cette stratégie autoritaire-policière. En réaction à ce modèle d'exclusion, un concept fut développé par les groupes d'entraide-mutuelle-SIDA un concept qui faisait confiance, au lieu de s'appuyer sur des lois fédérales sur les maladies épidémiques, à la prévention et aux structures d'entraide et recherchait à juguler la propagation du virus par l'information et l'explication médicales. *Safer sex* [le « *sexe plus sauf* » en anglais dans le texte, *ndt*], comme un codex clairement exprimé, devint l'axe et le point d'angle de la prévention. Sur les aides-SIDA, aux points de rencontre des scènes homosexuelles, les pratiques de protection de la santé furent formulées par des affiches dans un langage de vulgarisation accessible et conforme aux lieux (Roeßiger 2013). Le siège fédéral pour l' information sur la santé reprit cette stratégie aussi pour la population non-homosexuelle et fit de la publicité en faveur de l'utilisation de préservatifs lors de tous les contacts sexuels. De cette manière on parvint à déplacer la focalisation, de l'exclusion des groupes à risques vers un évitement des comportements à risques (Bänziger 2014).

Trois moments (Reichert 2018) au sujet de l'importance de la recherche de la campagne du s*afer-sex*, comme exemple d'une politique de santé démocratique-solidaire : Premièrement, la stratégie de prévention ne fut pas concoctée en des lieux étatiques, mais naquit au contraire d'une coopération des médecins, des chercheurs dans le domaine sexuel et des activistes homosexuels luttant contre le SIDA, pour ainsi dire à l'instar d'un projet transdisciplinaire, dans lequel, à partir de divers acteurs et de divers points de départ épistémiques on tenta de développer une solution au problème.

Deuxièmement, un débat officiel sur le *safer-sex* fut mené et des compromis furent réalisés. Alors qu'on plaidait en faveur d'une position d'abstinence ou de relations sexuelles limitées au couple, il fut objecté du côté de la recherche scientifique sur le sexe, que l'instinct sexuel ne se laisse pas simplement « déconnecté », même pas non plus par des discernements rationnels. À cela se rajouta la position que la promiscuité sexuelle est une lutte pour la liberté et ne doit pas être abandonnée — même dans une crise. Dans cette mesure, la ligne finalement négociée de l'entraide-SIDA représente un compromis entre les acteurs : défense des droits de liberté et canalisation de ces droits au moyen de la prévention (Dannecker 2019, p.195).

Troisièmement, la prise de mesures suit les stricts principes de solidarité, de réciprocité et d'engagement Les règles du *safer-sex* se caractérisent par le fait qu'elles valent comme modèles de comportement pour tous, et pas seulement pour les seuls malades du SIDA. Au lieu de chausser des lunettes épidémiologiques, on chaussa des lunettes sociales-politiques. La solidarité entre infectés et non-infectés reposait sur le principe d'une stricte réciprocité : l'utilisation du préservatif n'était plus seulement un moyen égoïste de se protéger contre l'infection, mais encore un moyen altruiste, en entravant la transmission à d'autres. La protection de soi et la protection des autres convergent un un acte. À cela se rajoute le fait que l'obéissance aux règles du *safer-sex* ne représentait plus une décision personnelle, mais une norme morale, qui valait sans considération de chaque partenaire sexuel et aussi (tendanciellement) indépendamment du modèle de relation.

Bilan : répercussions pour la façon de s'y prendre avec le virus-corona

Si l'on part des trois règles : solidarité, réciprocité et engagement, comme principes de conduite pouvant être utiles dans la pandémie coronaïque, alors des possibilités de penser et d'action s'ouvrent sur la manière dont le modèle de la variole peut être développé pour la lutte actuelle en un modèle sociétal innovateur. De manière analogue aux règles du *safer sex*, la vaccination agit pareillement de manière solidaire et réciproque. Dans l'acte de vaccination se trouve justement aussi un motif égoïste (moi, je me protège) mais aussi un altruiste (je protège les autres), que ce soit en réduisant, par la vaccination, la vraisemblance d'être gravement infecté par le virus et avec cela aussi, en diminuant la possibilité de transmettre le virus. Ou bien encore en soulageant le système de santé qui peut ainsi maintenir ces capacités potentiels à la disposition de ceux qui en auront effectivement besoin. La même chose vaut aussi pour l'action tchèque présentée plus haut en ce qui concerne le port du masque.

Mais de fait, deux tendances se collisionnent l'une l'autre : d'une part la politique de la démocratie libérale envers un modèle-variole, qui au fond — selon Foucault — n'est pas un modèle orienté de manière sociétale mais néolibérale et qui représente une stratégie libertaire défendue par des groupes *lobbyistes*, qui veulent imposer leurs intérêts vers l'ouverture ; mais ce qui est décisif c'est le fait que les deux modèles se rencontrent en suivant une politique néo-libérale de privatisation des risques d'infection.

Si l'on veut découvrir une position médiane et saine dans cette polarité de réduction et de surenchère de l'individualité, alors celle-ci devrait reposer sur une mise en vigueur de l'élément relationnel de la société. Il vaut donc de s'engager pour des pratiques solidaires : en font partie le soutien du voisinage, la garde des enfants organisée de manière autonome, de nouveaux formats de formation et de discussion et la formation rapide d'un personnel de soins d'urgence avec des perspectives d'emplois à long terme.

Il s'agira avant tout de prendre en considération les changements qui se dessinent en ce moment dans l'organisation sociale. La sortie de la crise sera importante pour le futur même. Stratégies et institutionnalisations, une fois en place pourraient s'affirmer durablement dans le dos de leurs participants ou bien avec le plein dessein d'acteurs puissants — c'est ce qu'il faut apprendre de Foucault.

***Sozialimpulse* 4**/2021.

(Traduction Daniel Kmiecik)

Littérature

Bänziger, Peter-Paul (2004) : *Vom Seuchen-zum Präventionskörper ? Aids und Körperpolitik in der BRD un der Schweiz in der 1980er Jahren [De l'épidémie à la prévention des corps ? SIDA et politique corporelle en RFA et la Confédération helvétique dans les années 1980].* Dans ***Body Politics* 2**/2014, n°3, pp.179-214.

Camus, Albert (2000) : *La peste.* Hambourg

Dannecker, Martin ([1986] 2019) : *Offener Brief an Rudolf Augstein [Lettre ouverte à Rudolf Augstein]*, dans : Dannecker, Martin (éditeur) : *Fortwährende Eingriffe [Interventions constantes]*. Berlin

Dannecker, Martin (2019) : *Fortwährende Eingriffe. Aufsätze, Vorträge und Reden aus vier Jahrzehnten zu Aids and HIV [Interventions constantes. Essais, conférences et discours tiré des quarante ans de SIDA et de HIV]* Berlin

Habermas, Jürgen (2020) : *Jürgen Habermas über Corona : « So viel Wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie [Jürgen Habermas sur la corona : « Il n'y a jamais eu autant de savoir sur notre non-savoir. »* ***Frankfurter Rundschau*** du 10 avril 2020. https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/juergen-habermas-corona-virus-krise-covid19-interview-1364249.html (consulté le 9/12/2021)

Hegel, Georg F. W. (1972) : *Grundlinien der Philosophie des Rechts [Grandes lignes d'une philosophie du droit]*, Francfort-sur-le-Main

Foucault, Michel (2004) : *Geschichte der Gouvernementalität* ***1.*** *Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Vorlesung am College de France [Histoire de la gouvernementalité* ***1.*** *Sécurité, territoire, population.]* Cours au Collège de France 1977-1978, Francfort sur-le-Main

Foucault, Michel (2001-2005) : *Schriften in vier Bänden [Écrits en quatre tomes] [Dits & Écrits]*, édité par Daniel Defert & François Ewald, Francfort 2001-2005, ; Vol. III.

Foucault, Michel (2001) : *Die Ordnung des Diskurses [L'ordre du discours]* Francfort-sur-le-Main

Foucault, Michel (1994) : *Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses [Surveiller et punir : Naissance de la prison]* Francfort-sur-le-Main

Foucault, Michel (1973) : *Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft [Folie et société. Une histoire de la folie à l'âge classique]* Francfort-sur-le-Main

Kieser, Alfred (1998) : *From Freemassons to Industrious Patriots. Organizing and Disciplining in the 18th Century [Des francs-maçons aux patriotes industrieux. Organisation et disciplinement au 18ème siècle]* dans ***Organization Studies***, vol. **19**, 1998 : pp.42-47.

Katíková, Irena (2020) : *#Masks4All. Movement for Population-Wide Use of Homemade Masks as Critical Protective Equipment Against Covid-19. Die Geschichte [Mouvement pour l'usage populaire du masque fait maison comme équipement crucial de protection contre le Covid-19. L'histoire].*— #Masks4All (consulté le 10/12/2021)

Lorey, Isabell (2009) : *Identitäre Immunität und strategische Immunisierung. Lépra und Lepra von der Bibel bis in Mittelalter [Immunité identitaire et stratégie d'immunisation. Lèpre et lèpre de la Bible jusqu'au Moyen-Âge]* dans Claudia Brunner, Gabrielle Dietze et Edith Wenzel (éditrices), *De/Konstruktion von Okzidentalismus. [Dé/Construction de l'occidentalisme)* Bielefeld

Reichert, Martin (2018) : *Die Kapsel. AIDS in der Bundesrepublik Deutschland [La capsule, le SIDA en RFA*] Berlin

Roeßiger, Suzanne (2013) : *Safer sex und Solidarität. Die Sammlung internationaler Aisdplakate im Deutschen Hygiene-Museum. Zeithistorische Forschungen [|Le sexe sauf et la solidarité. Le recueil des affiches SIDA internationales au Musée de l'hygiène allemand. Investigations d'histoire contemporaine]* dans ***Studies in Contemporary History* 3**/2013 [Zeitgeschichte der Vorsorge] [Histoire contemporaine de la prévention], pp.502-514.

André Bleicher : est né en 1963 ; formation d'électromécanicien, études sur la gestion d'entreprise et la sociologie, membre fondateur de l'Institut Lorenz Oken à Herrischried et de l'Institut pour les questions sociales du présent à Stuttgart, dont il est membre du *Vorstand* depuis 2015. Activité comme développeur d'organisations et de coopérations dans les réseaux des petites et moyennes entreprises, collaborateur scientifique au *BTU Cottbus* et de l'université de Leipzig, professeur invité pour l'institutionnalisme coopératif de l'université *Lumière II* de Lyon, professeur de développement des affaires et de l'économie au *FH Salzburg* depuis 2012 à l'université Biberach et recteur du lieu depuis 2017.